

Obezita a kardiometabolické zdravie pri chorobe obličiek: od životného štýlu k viaczožkovej stratégii

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.09.2026

Obezita už dávno nie je len sprievodným javom chronickej choroby obličiek (CKD). Je samostatným patofyziologickým činiteľom, ktorý zvyšuje riziko vzniku aj progresie ochorenia obličiek, urýchljuje kardiovaskulárne komplikácie a zhoršuje metabolický profil pacienta. Prehľadová práca Mathewa a kolektívu, publikovaná v roku 2026 v časopise *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, tieto väzby zhŕňa v rámci **kardio-obličkovo-metabolického (CKM) rámca**.

Pre nefrologickú prax je podstatný posun v uvažovaní: obezitu netreba vnímať ako komorbiditu vedľa CKD, ale ako stav, ktorý priamo ovplyvňuje hemodynamiku obličky, zápal, glomerulárny tlak, albuminúriu aj dlhodobú prognózu.

Ako obezita poškodzuje obličku

Prehľad rozlišuje **priame a nepriame mechanizmy**, čo je pri klinickej úvahe užitočné rozlíšenie:

Dráha	Mechanizmus	Klinický prejav
Priama	Glomerulárna hyperfiltrácia a zvýšený intraglomerulárny tlak	Proteinúria, zväčšenie glomerulov, poškodenie podocytov
Priama	Tubulárne poškodenie	Tubulointersticiálne zmeny nezávislé od glomerulárnej dráhy
Nepriama	Diabetes, hypertenzia, kardiovaskulárno-metabolické ochorenie	Progresia CKD cez etablované rizikové faktory

K tomu sa pridáva zápalová a hormonálna aktivita tukového tkaniva. Tukové tkanivo nie je pasívnym zásobným orgánom – produkuje cytokíny a adipokíny, ktoré prispievajú k systémovému zápalu, endotelovej dysfunkcii, inzulinovej rezistencii a fibrotizácii. Obezita zároveň podporuje aktiváciu systému renín-angiotenzín-aldosterón a sympatikového nervového systému, čo zhoršuje hypertenziu aj tlakové zaťaženie glomerulu.

Klinicky podstatné je, že obezita môže poškodzovať obličku **aj bez prítomnosti diabetu**. Tento obraz sa označuje ako obezitná glomerulopatia a typicky sa prejavuje proteinúriou s pomalou progresiou. Môže sa však kombinovať s inými nefropatiami a urýchľovať ich priebeh.

Nie hmotnosť, ale rozloženie tuku

Jedným z najpraktickejších posolstiev prehľadu je, že **rozloženie tukového tkaniva ovplyvňuje poškodenie cieľových orgánov**. Pribúdajú dôkazy, že s CKD súvisia predovšetkým **viscerálne a ektopické perirenálne tukové depozity** – nie samotná celková hmotnosť.

Populačné štúdie to potvrdzujú: ukazovatele adipozity sa spájajú s vyšším rizikom vzniku CKD, jej progresie aj zlyhania obličiek.

Z toho vyplýva priamy dôsledok pre hodnotenie pacienta. **Index telesnej hmotnosti (BMI) je praktický, ale sám osebe nedostatočný**. U niektorých pacientov neodráža ani metabolické riziko, ani zloženie tela – najmä u starších osôb, pri sarkopénii a pri chronickom ochorení. Pri hodnotení preto patrí k BMI aj obvod pásu, posúdenie viscerálnej adipozity, krvný tlak, glykemický stav, albuminúria, eGFR, lipidový profil, známky spánkového apnoe a funkčná zdatnosť vrátane rizika sarkopénie.

Posun v liečbe: od režimu k viaczožkovej stratégii

Hlavná téza prehľadu je, že s príchodom novších liekov sa manažment obezity pri CKD **presunul od prevažne režimového prístupu k ucelenej viaczožkovej stratégii**. Tá kombinuje farmakoterapiu s preukázaným kardio-obličkovo-metabolickým prínosom so štruktúrovaným nutričným vedením, individualizovanou pohybovou

aktivitou a dlhodobou behaviorálnou podporou.

Režimové opatrenia

Základom zostáva energetická reštrikcia, zvýšenie pohybovej aktivity, obmedzenie ultraspracovaných potravín, primeraný príjem bielkovín a dlhodobá edukácia. Samotná režimová intervencia však býva nedostatočná, ak nie je sprevádzaná multidisciplinárnou starostlivosťou – a to nie je zlyhanie pacienta, ale očakávaný priebeh.

Inkretínová liečba

Prehľad označuje inkretínovú liečbu za prístup, ktorý **predefinoval liečebné postupy**. Agonisty receptora GLP-1 a duálne inkretínové agonisty pôsobia súčasne na metabolickú dysfunkciu, progresiu CKD aj kardiovaskulárne riziko.

Pripravované sú **trojité inkretínové agonisty**, ktoré sľubujú ešte väčšiu účinnosť v redukcii hmotnosti a metabolickej kontrole. Tu však prehľad výslovne upozorňuje, že **údaje o ich účinnosti a bezpečnosti pri chorobe obličiek zostávajú obmedzené** – ide o očakávanie, nie o doložený prínos.

Pre nefrológa je pri inkretínovej liečbe podstatné sledovať znášanlivosť, objemový stav, gastrointestinálne nežiaduce účinky, nutričný stav a možné interakcie s ostatnou liečbou.

SGLT2 inhibítory

SGLT2 inhibítory navodzujú **mierny úbytok hmotnosti**, a to prevažne stratou kalórií pri glykozúrii, pričom súčasne poskytujú kardio-obličkovú ochranu. Ich úloha pri obezite je teda doplnková – nie sú liekom na chudnutie, ale ich metabolický efekt je vítaným pridaným účinkom pri liečbe, ktorá je pri CKD indikovaná z iných dôvodov.

Bariatrická a metabolická chirurgia

Klinické štúdie ukazujú, že bariatrická chirurgia dosahuje **podstatný úbytok hmotnosti** a pri CKD sa spája so zlepšením kardio-obličkových výsledkov. U pacientov s CKD môže priniesť zlepšenie hypertenzie, redukcii proteinúrie a zlepšenie kontroly diabetu.

Treba však počítať s perioperačnými komplikáciami, výživovými deficitmi, rizikom nefrolitiázy a s potrebou dlhodobého sledovania minerálov, vitamínov a nutričného stavu. U pacienta s CKD je riziko oxalátovej nefrolitiázy po malabsorpčných výkonoch osobitne relevantné.

Opatrná interpretácia takzvaného obezitého paradoxu

V nefrológii sa dlhodobo diskutuje pozorovanie, že u niektorých skupín chronicky chorých – najmä u dialyzovaných pacientov – sa vyšší BMI spája s lepším prežívaním. Tento nález nemožno interpretovať zjednodušene.

Medzi možné vysvetlenia patrí obrátená kauzalita, vplyv sarkopénie a kachexie, rozdiel medzi BMI a skutočným metabolickým rizikom a výberové skreslenie v kohortách. Pre prax z toho vyplýva, že obezita zostáva rizikovým faktorom, redukcia hmotnosti však musí byť individualizovaná a cieľom nie je nižšie číslo na váhe, ale lepšie kardiometabolické a obličkové zdravie pri zachovaní svalovej hmoty.

Praktické odporúčania pre nefrologickú prax

1. U každého pacienta s CKD aktívne hodnotiť obezitu, metabolické riziko a kardiovaskulárne komorbidity – nie iba zaznamenať hmotnosť.
2. Nepodceňovať albuminúriu a krvný tlak; pri obezite môžu byť prvými známkami poškodenia obličiek.
3. Hodnotiť **rozloženie tuku**, nie iba BMI; pri sarkopénii a u starších pacientov je BMI obzvlášť nespoľahlivé.
4. U vhodných pacientov zvážiť inkretínovú liečbu s preukázaným kardio-obličkovým prínosom, pri trojitých agonistoch však počítať s obmedzenými dátami pri CKD.
5. Pri ťažkej obezite posúdiť indikáciu bariatrickej alebo metabolickej chirurgie vrátane plánu dlhodobého nutričného sledovania.
6. Využívať multidisciplinárny model – nefrológ, diabetológ, kardiológ, nutričný špecialista a obezitológ.

7. Komunikovať bez stigmatizácie; stigmatizujúci prístup znižuje adhérenciu a je sám osebe prekážkou úspešnej liečby.

Limity

Ide o **naratívny prehľad**, nie o systematickú syntézu s vlastnou metaanalýzou. Zhrňa dôkazy rôznej sily – od populačných asociačných štúdií cez randomizované skúšania inkretínovej liečby až po observačné údaje o bariatrickej chirurgii. Odporúčanie stupňovitého postupu je expertné, nie gradované. Pri trojitých inkretínových agonistoch a pri viacerých postupoch v pokročilých štádiách CKD dôkazy stále chýbajú.

Záver

Obezita je pri CKD kľúčovým modifikovateľným činiteľom, ktorý zasahuje do patogenézy aj prognózy. V rámci CKM prestáva byť samostatným pridruženým problémom a stáva sa súčasťou liečebnej stratégie.

Pre klinickú prax je najdôležitejšie myslieť na obezitu ako na ochorenie s obličkovými dôsledkami, sledovať pacienta komplexne a nie iba podľa BMI, cielene liečiť metabolické a kardiovaskulárne riziko a u vhodných pacientov využiť moderné farmakologické aj chirurgické možnosti – s vedomím, kde dôkazy pri chorobe obličiek ešte končia.

Súvisiace články na portáli

- [Obezita a obličky](#)
- [Oblička v strede pozornosti: KDIGO a CKM syndróm](#)
- [Farmakologická liečba obezity pri pokročilej CKD a na dialýze](#)
- [Obezita ako multifaktoriálne ochorenie: skrining v nefrologickej praxi](#)
- [Éra GLP-1: nový model starostlivosti o obezitu v nefrológii](#)

Hlavný zdroj: Mathew RO, Hong A, Narasaki Y, Fung E, Cheung D, Han J, Durstenfeld MS, Hsue PY, Rhee CM. Obesity and Cardio-Metabolic Health in Kidney Disease: Implications for Kidney Health, Risk Stratification, and Management. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2026. doi:10.2215/CJN.0000001233. PMID 42726513. [DOI](#); [PubMed](#).

Ďalšie zdroje:

1. Ndumele CE, Neeland IJ, Tuttle KR, a kol. A Synopsis of the Evidence for the Science and Clinical Management of Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Syndrome: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2023;148(20):1636–1664. doi:10.1161/CIR.0000000000001186. PMID 37807920. [DOI](#); [PubMed](#).
2. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, a kol. Empagliflozin and Progression of Kidney Disease in Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*. 2016;375(4):323–334. doi:10.1056/NEJMoa1515920. PMID 27299675. [DOI](#); [PubMed](#).
3. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, a kol. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. *New England Journal of Medicine*. 2020;383(15):1436–1446. doi:10.1056/NEJMoa2024816. PMID 32970396. [DOI](#); [PubMed](#).
4. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, a kol. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. *New England Journal of Medicine*. 2022;387(3):205–216. doi:10.1056/NEJMoa2206038. PMID 35658024. [DOI](#); [PubMed](#).
5. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. [kdigo.org](#).
6. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. [kdigo.org](#).

Bibliografické údaje boli overené v databáze PubMed 17. septembra 2026. Ide o naratívny prehľad; odporúčania v ňom nie sú gradované. Text nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani schválenú informáciu o lieku.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=obezita-kardiometabolicke-zdravie-ckd-ckm-ramec> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.